Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5322248-94.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: ANTONIO FAUSTO DOS SANTOS OSORIO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ANTONIO FAUSTO DOS SANTOS OSORIO ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **Adenocarcinoma Gástrico (CID10-C16)** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Trastuzumabe**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência (evento 38, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 66, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 74, CONT1).

Não houve réplica (evento 79).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 81, DESPADEC1), o demandado requereu a produção de prova documental (evento 86, PET1) e o autor não se manifestou (evento 88).

A parte autora informou a alteração da medicação prescrita e solicitou a concessão do medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (evento 95, PED LIMINAR_ANT TUTE1).

Deferido o pedido de substituição da medicação (evento 118, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o novo fármaco postulado (evento 126, OFIC1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 131, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência e o pedido de substituição foram deferidos, os quais abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 38, DESPADEC1; evento 118, DESPADEC1):

> *Segundo o **laudo médico** acostado aos autos, a parte autora apresenta o diagnóstico de Adenocarcinoma Gástrico – HER-2 hiperexpresso, CID-10: C16, atualmente em estágio clínico IV, necessitando fazer uso do medicamento **TRASTUZUMABE.** Ressaltou a **urgência** do tratamento (evento 1, LAUDO4):*
>
> *[...]*
>
> *Em consulta ao banco de dados de notas técnicas emitidas pelo ENATJUS, é possível encontrar pareceres favoráveis[1] ao fornecimento do medicamento para pacientes com o mesmo diagnóstico do autor:*
>
> *[...]*
>
> *Ademais, foi juntada ao feito a **negativa administrativa** do IPE-SAÚDE (evento 1, OUT5).*

Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.

Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao IPE-SAÚDE que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **TRASTUZUMABE**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento.*

Primeiramente, esclareço que o requerimento de substituição/inclusão de um fármaco/procedimento/tratamento, além dos já deferidos em sede de tutela antecipada, não implica em alteração do pedido, uma vez que o objeto da ação é o tratamento da patologia que acomete a parte autora.

*Ante o exposto, considerando a) que autor encontra-se internado na Santa Casa há quase um ano, b) a piora do quadro clínico, c) não haver indicação atual de abordagens cirúrgicas ou outras terapias locais, e d) a necessidade de reestabelecimento da via de alimentação gastrointestinal para possível desospitalização, **DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO** formulado e determino ao **IPÊ-Saúde** que passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **TRATUZUMABE DERUXTECANA**, nos termos do receituário médico juntado (evento 95, RECEIT4), o qual deverá ser atualizado pela parte autora semestralmente.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 95, ATESTMED3), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **Adenocarcinoma Gástrico (CID10-C16)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento, salientando o laudo médico que o uso mais breve possível da medicação evitará a piora clínica progressiva, a expansão do volume tumoral, o aumento do comprometimento funcional dos órgãos e o risco de morte. Senão vejamos:

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

PACIENTE

ANTONIO FAUSTO DOS SANTOS OSORIO CPF: 556.274.630-15

Atestado Médico

Atesto que o paciente ANTONIO FAUSTO DOS SANTOS OSORIO tem diagnóstico de patologia CID C16 - Adenocarcinoma Gástrico recidivado e com quadro de suboclusão intestinal por carcinomatose peritoneal.
Paciente submetido a gastrectomia em 2023 e houve recidiva precoce de doença. Está internado na Santa de Casa de Poa há mais de 06 meses devido a quadro de suboclusão intestinal decorrente de carcinomatose peritoneal, atualmente houve piora do quadro obstrutivo intestinal e paciente alimenta-se exclusivamente por nutrição parenteral total. Não tem indicação atual de abordagens cirúrgicas ou outras terapias locais. Paciente necessita iniciar tratamento de segunda linha com trastuzumabe deruxtecana, 6,4 mg/kg EV, a cada 3 semanas. O uso da medicação citada, nesse contexto clínico, é amparado por indicação na bula brasileira do fármaco e por consensos técnicos de reconhecimento internacional como o NCCN (National Comprehensive Cancer Network; http://nccn.org). Há evidências clínicas em ensaios de fase II/III que demonstram que trastuzumabe deruxtecana foi superior à quimioterapia em taxa de resposta (51 versus 14%; p<0,0001) e em sobrevida global (HR=0,59; 12,5 versus 8,4 meses; p=0,009), em pacientes previamente expostos a anti-HER-2 (TRASTUZUMABE). A história natural da patologia citada quando não exposta a medicações que possam alterar a sua história natural é de piora clínica progressiva, expansão do volume tumoral, aumento do comprometimento funcional dos órgãos acometidos e substancial aumento do risco de morte. Dado o exposto, ratifica-se a indicação de início URGENTE do uso de taL medicações , sem interrupções não-programadas e associada com a manutenção do acompanhamento oncológico vigente. Ressalto que paciente encontra-se em internação hospitalar prolongada, e atualmente há impossibilidade de alimentação por via oral, devido a quadro suboclusivo, sendo necessário alimentação parenteral total para manutenção da vida.

O estudo clínico pode ser acessado em:
N Engl J Med 382:2419, 2020; Ann Oncol 31:abstr O-11, 2020
[J Clin Oncol 40:abstr 242, 2022

Cabe ressaltar, que tal medicação não consta em protocolo de diretrizes clínicas do Ipê Saúde e por este motivo, não há possibilidade de solicitar o tratamento via portal do Ipê e dessa forma não há negativa pelo plano de saúde.

13 de Maio de 2025

Este documento foi emitido e assinado digitalmente por DAIANA REGINA SCHEID 40651/RS através do sistema ESPACO MEDICO do CREMERS em 13/05/2025 07:38:13

DAIANA REGINA SCHEID CRM-RS: 40651

Oncologia Clínica (RQE: 39775), Clínica Médica (RQE: 39535)

Endereço Comercial: PROFESSOR ANNES DIAS, Nº 295, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

ICP Brasil

Atestado emitido no dia 13/05/2025 07:38:13 por DAIANA REGINA SCHEID - 40651/RS para ANTONIO FAUSTO DOS SANTOS OSORIO (CPF: 556.274.630-15 marciaosorio493@gmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-preecricao/#/validador/atestado/6oOwudLo** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Com efeito, o(a) médico(a) assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo(a) médico(a) assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do(s) medicamento(s) postulado(s) ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por ANTONIO FAUSTO DOS SANTOS OSORIO em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Tratuzumabe Deruxtecana,** na dosagem e periodicidade determinadas pela médica assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao(à) procurador(a) da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 12/09/2025, às 17:34:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090891187v7** e o código CRC **f1d1d2b5**.

---

1. https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:276137:1735589391:be47cf8fa825a85de22b10e3ccfd0609236881548d0d932467087371bc889073https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:263609:1735589391:f1a2247ea3b118e5b9b51637627954db1913160b0b9224c7d23af65dfaf857d5 ↩